

Terapia familiar estrutural

A organização subjacente da vida familiar

Uma das razões pelas quais a terapia familiar pode ser difícil é as famílias com frequência parecerem conjuntos de indivíduos que se influenciam mutuamente de maneiras poderosas, mas imprevisíveis. A terapia familiar estrutural oferece uma estrutura que traz ordem e significado a essas transações. Os padrões consistentes de comportamento familiar são o que nos permite considerar que eles têm uma estrutura, embora, é claro, somente em um sentido funcional. As fronteiras e coalizões que constituem uma estrutura familiar são abstrações; no entanto, utilizar o conceito de estrutura familiar permite aos terapeutas intervir de maneira sistemática e organizada.

As famílias que buscam ajuda em geral estão preocupadas com um problema específico. Pode ser uma criança que se comporta mal ou um casal que não consegue se relacionar bem. Os terapeutas familiares costumam olhar além dos elementos específicos desses problemas, para as tentativas da família de resolvê-los. Isso leva à dinâmica da interação. A criança que se comporta mal pode ter pais que a repreendem, mas jamais a recompensam. O casal pode estar aprisionado em uma dinâmica perseguidor-distanciador ou ser incapaz de conversar sem brigar.

O que a terapia familiar estrutural acrescenta à equação é o reconhecimento da organização total que sustenta e mantém essas interações. Os “pais que repreendem” podem acabar se revelando dois parceiros que se prejudicam porque um está emaranhado com a

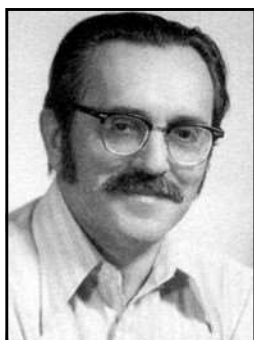
criança, enquanto o outro é um excluído zangado. Se for assim, tentativas de incentivar uma disciplina eficaz provavelmente fracassarão, a menos que o problema estrutural seja tratado, e os pais desenvolvam uma parceria genuína. Igualmente, um casal que não consegue se relacionar bem pode não ser capaz de melhorar seu relacionamento a menos que consiga criar uma fronteira entre eles e filhos ou parentes intrusivos.

A descoberta de que as famílias estão organizadas em **subsistemas** com **fronteiras** que regulam o contato que os membros da família mantêm se revelou um dos *insights* definidores da terapia familiar. Talvez de igual importância, todavia, tenha sido a introdução da técnica de **encenação**, em que os familiares são encorajados a lidar diretamente uns com os outros na sessão, o que permite que o terapeuta observe e modifique suas interações.

Quando Salvador Minuchin entrou em cena, seu impacto galvanizador foi como um mestre da técnica. Sua contribuição mais duradoura, entretanto, foi uma teoria da estrutura familiar e uma série de orientações para organizar as técnicas terapêuticas. Essa abordagem estrutural foi tão bem-sucedida que cativou o campo nos anos de 1970, e Minuchin transformou a Philadelphia Child Guidance Clinic em um complexo mundialmente famoso, no qual milhares de terapeutas familiares têm feito formação em terapia familiar estrutural.

ESBOÇO DE FIGURAS ORIENTADORAS

Minuchin nasceu e foi criado na Argentina. Trabalhou como médico no exército israel-



O modelo estrutural de Salvador Minuchin é a abordagem mais influente à terapia familiar em todo o mundo.

lense e depois foi para os Estados Unidos, onde se especializou em psiquiatria infantil com Nathan Ackerman, em Nova York. Após concluir seus estudos, Minuchin voltou a Israel, em 1952, para trabalhar com crianças refugiadas. Retornou aos Estados Unidos em 1954, para começar sua formação analítica no William Alanson White Institute, onde estudou a psiquiatria interpessoal de Harry Stack Sullivan. Ao deixar o White Institute, Minuchin trabalhou na Wiltwyck School com adolescentes delinquentes, onde sugeriu aos colegas que começassem a atender famílias.

Na Wiltwyck, Minuchin e seus colegas – Dick Auerwald, Charlie King, Braulio Montalvo e Clara Rabinowitz – aprenderam a fazer terapia familiar, inventando-a conforme iam em frente. Para isso, usavam um espelho de observação e se revezavam observando o trabalho uns dos outros. Em 1962, Minuchin fez uma peregrinação à Meca da terapia familiar, Palo Alto. Lá, conheceu Jay Haley, e ambos iniciaram uma amizade que frutificaria em uma colaboração extraordinariamente fértil.

O sucesso do trabalho de Minuchin com famílias na Wiltwyck levou à publicação de um livro influente e desbravador, *Families of the Slums*, escrito com Montalvo, Guernsey, Rosman e Schumer. A reputação de Minuchin como terapeuta familiar cresceu e, em 1965, ele se tornou diretor da Philadelphia Child Guidance Clinic. A clínica, na época, possuía uma equipe que não chegava a 12 pessoas. Partindo deste início modesto, Minuchin criou uma das clínicas de orientação infantil mais importantes e prestigiadas do mundo.

Entre os colegas de Minuchin na Philadelphia estavam Braulio Montalvo, Jay Haley,

Bernice Rosman, Harry Aponte, Carter Umbarger, Marianne Walters, Charles Fishman, Cloe Madanes e Stephen Greenstein, todos os quais participaram do desenvolvimento da terapia familiar estrutural. Nos anos de 1970, a terapia familiar estrutural já tinha se tornado o sistema de terapia familiar mais influente e amplamente praticado.

Em 1976, Minuchin deixou de ser diretor da Philadelphia Child Guidance Clinic, mas continuou como chefe do programa de formação até 1981. Depois de deixar a Philadelphia, Minuchin montou seu próprio centro em Nova York, onde continuou praticando e ensinando terapia familiar até 1996, quando se aposentou e se mudou para Boston. Nesse mesmo ano, concluiu seu nono livro, *Mastering family therapy: journeys of growth and transformation*, em co-autoria com nove de seus supervisionandos, apresentando as idéias mais importantes e significativas sobre terapia familiar e formação profissional na área. Embora tenha se aposentado (novamente) e se mudado para Boca Raton, na Flórida, em 2005, o Dr. Minuchin ainda viaja e ensina pelo mundo todo.

Como bons jogadores em uma equipe que tem uma superestrela, alguns dos colegas de Minuchin não são tão conhecidos como poderiam ser. Entre eles está Braulio Montalvo, um dos gênios subestimados da terapia familiar. Nascido e criado em Porto Rico, Montalvo, como Minuchin, sempre tratou famílias de minorias. Como Minuchin, também é um terapeuta brilhante, embora prefira uma abordagem mais gentil, mais apoiadora.

Após a aposentadoria de Minuchin, o centro de Nova York foi renomeado como Minuchin Center for the Family em sua homenagem, e a tocha foi passada adiante para uma nova geração. A equipe de professores eminentes no Minuchin Center atualmente inclui Ema Genijovich, David Greenan, George Simon e Wai-Yung Lee. Sua tarefa é manter o centro de vanguarda da terapia familiar estrutural na linha de frente do campo sem a liderança carismática de seu progenitor.

Entre outros alunos proeminentes de Minuchin estão Jorge Colapinto, agora no Ackerman Institute em Nova York; Michael Nichols, que leciona no College of William and Mary; Jay Lappin, que trabalha com assistência à criança para o governo de Delaware, e

Charles Fishman, em prática privada na Filadélfia.

FORMULAÇÕES TEÓRICAS

Os profissionais iniciantes tendem a se atolar no conteúdo dos problemas familiares porque não têm uma teoria que os ajude a enxergar os padrões de dinâmica familiar. A terapia familiar estrutural fornece um esquema para se analisar os processos de interação familiar. Como tal, oferece uma base para estratégias terapêuticas consistentes, que deixam óbvia a necessidade de se ter uma técnica específica – geralmente a de outra pessoa – para cada ocasião. Três construtos são os componentes essenciais da teoria familiar estrutural: estrutura, subsistemas e fronteiras.

Estrutura familiar refere-se ao padrão organizado em que os membros da família interagem. Já que as transações familiares se repetem, criam expectativas que estabelecem padrões duradouros. Depois que os padrões são estabelecidos, os membros da família usam apenas uma fração do leque completo de comportamentos disponíveis para eles. Da primeira vez em que um bebê chora ou um adolescente perde o ônibus escolar, não está claro quem fará o quê. A carga será compartilhada? Haverá uma desavença? Uma pessoa ficará encarregada de todo o trabalho? Mas logo são estabelecidos padrões, determinados papéis, e as coisas se tornam uniformes e previsíveis. “Quem fará...?” se torna “Provavelmente ela...” e, então, “Ela sempre...”.

A estrutura familiar é reforçada pelas expectativas que estabelecem regras na família. Por exemplo, uma regra como “os membros da família devem sempre se proteger mutuamente” vai se manifestar de várias maneiras, dependendo do contexto e de quem estiver envolvido. Se um menino briga com um vizinho, a mãe irá à casa dos vizinhos para se queixar. Se uma adolescente tem de acordar cedo para ir à escola, a mãe a acordará. Se um marido estiver com uma ressaca grande demais para ir trabalhar de manhã, a esposa telefonará para dizer que ele está gripado. Se os pais brigarem, os filhos interromperão a briga. Os pais estão tão preocupados com as questões dos filhos que isso os impede de passarem um tem-

po sozinhos, apenas os dois. Essas seqüências são *isomórficas*: são estruturadas. Modificar uma seqüência dessas pode não afetar a estrutura básica, mas alterar a estrutura subjacente terá um efeito sobre todas as transações familiares.

A estrutura familiar é moldada em parte por questões universais e em parte por limitações idiossincráticas. Por exemplo, todas as famílias têm uma estrutura hierárquica, com adultos e crianças possuindo mais ou menos autoridade. Os membros da família também tendem a ter funções recíprocas e complementares. Com frequência, essas funções se tornam tão entranhadas que sua origem é esquecida, e elas são vistas como necessárias, em vez de opcionais. Se uma jovem mãe, sobrecarregada pelas demandas do seu bebê, fica chateada e se queixa para o marido, ele pode responder de várias maneiras. Talvez ele se aproxime e ajude a cuidar do bebê. Isso cria uma equipe parental unida. Por outro lado, se ele decidir que a esposa está “deprimida”, ela pode acabar em terapia para conseguir o apoio emocional do qual precisa. Isso cria uma estrutura em que a mãe permanece distante do marido e aprende a buscar apoio fora da família. Seja qual for o padrão escolhido, ele tende a se autoperpetuar. Embora existam alternativas, as famílias provavelmente não as considerarão até que uma mudança nas circunstâncias produza estresse no sistema.

As famílias não chegam entregando-nos seus padrões estruturais como se estivessem entregando uma maçã para a professora. O que elas trazem é caos e confusão. Temos de descobrir o subtexto – e temos de cuidar para que ele seja acurado – não imposto, mas descoberto. Dois pontos são necessários: ter um sistema teórico que explique a estrutura e ver a família em ação. Saber que uma família é monoparental ou que um casal tem dificuldade com o filho do meio não nos diz qual é a sua estrutura. A estrutura só se torna observável quando observamos as interações concretas entre os membros da família.

Considere o seguinte caso. Uma mãe telefona para se queixar do mau comportamento de seu filho de 17 anos. Ela é convidada a trazer o marido, esse filho e os outros três para a primeira sessão. Quando chegam, a mãe começa a descrever uma série de aspectos triviais

que provam que o filho é desobediente. Ele interrompe para dizer que ela fica sempre no seu pé, que jamais lhe dá uma folga. Essa alteração espontânea revela um envolvimento intenso entre mãe e filho – uma preocupação mútua, não menos intensa por ser conflituosa. Contudo, essa seqüência não nos conta toda a história, porque não inclui o pai nem os outros filhos. Eles precisam ser envolvidos para observarmos seu papel na estrutura familiar. Se o pai tomar o partido da esposa, mas parecer despreocupado, pode ser que a preocupação da mãe com o filho esteja relacionada à falta de envolvimento do marido. Se os filhos mais jovens tenderem a concordar com a mãe e descreverem o irmão como mau, fica claro que todos os filhos são próximos da mãe – próximos e obedientes até certo ponto, depois próximos e desobedientes.

As famílias diferenciam-se em *subsistemas* baseados em geração, gênero e interesses comuns. Agrupamentos óbvios como os pais ou os filhos adolescentes são, às vezes, menos significativos que coalizões encobertas. Uma mãe e seu filho caçula podem formar um subsistema tão fechado que os outros são excluídos. Outra família pode se dividir em dois campos, com a mãe e o filho de um lado, e o pai e a filha de outro. Embora certos padrões sejam comuns, as possibilidades de subagrupamentos são infinitas.

Cada membro da família desempenha muitos papéis em vários subgrupos. Mary pode ser esposa, mãe, filha e sobrinha. Em cada um desses papéis, pode ser exigido dela um comportamento diferente. Se ela for flexível, será capaz de variar seu comportamento e adaptá-lo a diferentes subgrupos. Censurar pode estar bem para uma mãe, mas pode causar problemas a uma esposa ou filha.

Os indivíduos, subsistemas e a família inteira são demarcados por *fronteiras* interpessoais, barreiras invisíveis que regulam o contato com os outros. Uma regra que proíbe telefonemas durante o jantar estabelece uma fronteira que protege a família de intrusões externas. Quando as crianças pequenas têm permissão para interromper livremente a conversa dos pais, a fronteira que separa as gerações é desgastada. Subsistemas que não são adequadamente protegidos por fronteiras limitam o desenvolvimento de habilidades interpessoais exequíveis nos mesmos. Se os pais sempre interferem para re-

solver as disputas dos filhos, estes não aprenderão a lutar suas próprias batalhas.

As fronteiras interpessoais variam de rígidas a difusas (ver Figura 7.1). Fronteiras rígidas são excessivamente restritivas e permitem pouco contato com subsistemas externos, resultando em *desligamento*. Indivíduos ou subsistemas desligados são independentes, mas isolados. Do lado positivo, isso estimula a autonomia. Por outro lado, o desligamento limita a afeição e a ajuda. Famílias desligadas precisam chegar a um estresse extremo antes de mobilizarem ajuda mútua.

Os subsistemas *emaranhados* fornecem um sentimento amplo de apoio mútuo, mas à custa da independência e da autonomia. Pais emaranhados são amorosos e atenciosos; passam muito tempo com os filhos e fazem muito por eles. Entretanto, os filhos emaranhados com os pais tornam-se dependentes. Sentem-se menos à vontade sozinhos e podem ter dificuldade em se relacionar com pessoas de fora da família.

Minuchin descreveu algumas das características dos subsistemas familiares em seu trabalho mais acessível, *Families and family therapy* (Minuchin, 1974). A família começa quando duas pessoas se unem para formar um casal. Duas pessoas que se amam concordam em compartilhar a vida, o futuro e as expectativas, mas um período de ajustamento, geralmente difícil, é necessário antes que elas possam completar a transição do namoro para uma parceria funcional. Elas precisam aprender a *acomodar* as necessidades mútuas e os estilos preferidos de interação. Em um casal sadio, ambos dão e recebem. Ele aprende a acomo-

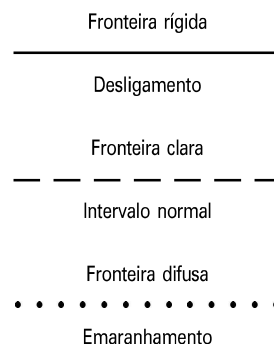


FIGURA 7.1 Fronteiras.

dar a necessidade dela de ser beijada na despedida e na chegada. Ela aprende a deixá-lo em paz com seu jornal no café da manhã. Esses pequenos arranjos, multiplicados milhares de vezes, podem ser feitos facilmente ou só depois de muitas brigas. Seja como for, esse processo de acomodação cimenta o casal em uma unidade.

O casal também precisa desenvolver padrões complementares de apoio mútuo. Alguns padrões são transitórios e podem ser revertidos mais tarde – por exemplo, um vai trabalhar enquanto o outro termina a faculdade. Outros padrões são mais duradouros. Papéis complementares exagerados podem dificultar o crescimento individual; papéis complementares moderados permitem ao casal dividir funções, apoiar-se e enriquecer-se mutuamente. Quando um fica gripado, o outro assume as tarefas. A permissividade de um deles com os filhos pode ser equilibrada pela firmeza do outro. A disposição impetuosa de um pode ajudar a dissolver a reserva do outro. Padrões complementares existem na maioria dos casais. Tornam-se problemáticos quando são tão exagerados que criam um subsistema disfuncional.

O subsistema dos cônjuges também precisa criar uma fronteira que o separe de pais, filhos e outras pessoas de fora. Quando os filhos nascem, é muito comum marido e mulher desistirem do espaço que lhes é necessário para se apoiarem. Uma fronteira rígida demais em torno do casal pode privar os filhos dos cuidados de que eles precisam; mas, na nossa cultura centrada nas crianças, a fronteira entre pais e filhos frequentemente é ambígua, no melhor dos casos.

Uma fronteira clara permite aos filhos interagir com pais, mas os exclui do subsistema do casal. Pais e filhos comem juntos, brincam juntos e compartilham grande parte da vida uns dos outros, mas há algumas funções do casal que não precisam ser compartilhadas. Marido e mulher são reforçados como casal amoroso e melhorados como pais se tiverem tempo para ficarem sozinhos – para conversar, sair para jantar ocasionalmente, brigar e fazer amor. Infelizmente, as demandas barulhentas dos filhos pequenos muitas vezes fazem os pais perderem de vista a sua necessidade de manter uma fronteira em torno de seu relacionamento.

Além de manter a privacidade do casal, uma fronteira clara estabelece uma **estrutura hierárquica** em que os pais ocupam uma posição de liderança. Com frequência excessiva, essa hierarquia é rompida por uma disposição centrada na criança, que influencia os profissionais que atendem crianças, assim como os pais. Pais emaranhados com seus filhos tendem a discutir com eles sobre quem está no comando e compartilham equivocadamente – ou negligenciam – a responsabilidade por tomar decisões parentais.

Em *Institutionalizing madness* (Elizur e Minuchin, 1989), Minuchin defende convincentemente uma visão sistêmica dos problemas familiares que vai além da família e inclui toda a comunidade. Conforme Minuchin salienta, a menos que os terapeutas aprendam a olhar além da fatia limitada da ecologia em que trabalham, para as estruturas sociais mais amplas nas quais seu trabalho está inserido, sua obra talvez se reduza a pouco mais do que fiar em uma roca.

DESENVOLVIMENTO FAMILIAR NORMAL

O que distingue uma família normal não é a ausência de problemas, mas uma estrutura funcional para lidar com eles. Todo casal precisa aprender a se ajustar um ao outro; a criar os filhos, se decidir ter filhos; a lidar com os pais; a lidar com seus empregos, e a se adaptar à comunidade. A natureza dessas lutas se modifica de acordo com os estágios desenvolvimentais e as crises situacionais.

Quando duas pessoas se unem para formar um casal, os requerimentos estruturais da nova união são a *acomodação* e a *criação de fronteiras*. A maior prioridade é a mútua **acomodação**, para lidar com os inúmeros detalhes da vida cotidiana. Cada parceiro tende a organizar o relacionamento segundo uma linha familiar e pressiona o outro para aceitar isso. Eles precisam concordar em relação a questões importantes, tais como onde morar e se e quando terão filhos. Menos óbvio, mas igualmente importante, precisam coordenar rituais diários, tais como os programas aos quais assistir na televisão, o que comer no jantar, a que horas ir para a cama e o que fazer lá.

Nesta acomodação mútua, o casal também precisa negociar a natureza das fronteiras entre eles e das fronteiras que os separam dos outros. Uma fronteira difusa entre o casal é aquela em que ambos costumam se telefonar durante o trabalho, em que nenhum tem amigos próprios ou atividades independentes e em que passam a se ver como um par, e não como duas personalidades diferentes. Por outro lado, a fronteira é rígida se eles passam pouco tempo juntos, têm quartos separados, tiram férias separadamente, têm contas separadas no banco, e ambos investem mais na carreira ou em relacionamentos externos do que no casamento.

Cada parceiro tende a se sentir mais à vontade com o nível de proximidade que existia em sua família. Já que essas expectativas diferem, segue-se uma luta que pode ser o aspecto mais difícil da nova união. Ele quer jogar golfe com os rapazes; ela se sente abandonada. Ela quer conversar; ele quer assistir à ESPN. O foco dele é a sua carreira; o foco dela é o relacionamento. Cada um acha que o outro não está sendo razoável.

Os casais também precisam definir uma fronteira que os separe de suas famílias de origem. De repente, as famílias em que cresceram passam a segundo plano no novo casamento. Este, também, é um ajustamento difícil, tanto para os recém-casados quanto para seus pais. As famílias variam na facilidade com que aceitam e apóiam essas novas uniões.

O nascimento de um filho transforma instantaneamente a estrutura da nova família, criando um *subsistema parental* e um *subsistema filial*. É típico os cônjuges terem padrões diferentes de comprometimento com o bebê. O comprometimento da mulher com uma unidade de três provavelmente começa com a gravidez, pois o bebê dentro de seu útero é uma realidade inevitável. O marido, por outro lado, talvez só comece a se sentir pai quando o filho nascer. Muitos homens não aceitam o papel de pai até os filhos terem idade suficiente para reagir a eles. Assim, mesmo em famílias normais, os filhos trazem consigo grande potencial de estresse e conflito. A vida da mãe em geral é transformada mais radicalmente que a do pai. Ela se sacrifica muito e, tipicamente, precisa de mais apoio por parte do marido. O marido, enquanto isso, continua trabalhando, e o novo bebê não altera tanto a sua vida.

Embora possa tentar ajudar a esposa, é provável que veja algumas de suas exigências como desmedidas.

Os filhos requerem diferentes estilos de cuidados parentais nas diferentes idades. Os bebês precisam basicamente de cuidados e carinho. As crianças precisam de orientação e controle, e os adolescentes, de independência e responsabilidade. O que representa bons cuidados parentais para uma criança de 2 anos pode ser inadequado para uma de 5 ou para um adolescente de 14 anos.

Minuchin (1974) alerta os terapeutas familiares para que não confundam as dores do crescimento com patologia. A família normal sente ansiedade e tem problemas conforme seus membros se adaptam ao crescimento e à mudança. Muitas famílias buscam ajuda em estágios transicionais, e os terapeutas devem ter em mente que elas podem, simplesmente, estar no processo de modificar sua estrutura para acomodar novas circunstâncias.

Todas as famílias enfrentam situações que estressam o sistema. Embora não exista nenhuma linha divisória clara entre famílias sadias e não-sadias, podemos dizer que as famílias sadias modificam sua estrutura para acomodar circunstâncias modificadas; as famílias disfuncionais aumentam a rigidez das estruturas e deixam de ser efetivas.

DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO

Os sistemas familiares precisam ser suficientemente estáveis para garantir continuidade, mas suficientemente flexíveis para se acomodar a mudanças nas circunstâncias. Os problemas surgem quando estruturas familiares inflexíveis não conseguem se ajustar de forma adequada a desafios maturacionais ou situacionais. Mudanças adaptativas na estrutura são necessárias quando a família ou um de seus membros enfrenta um estresse externo e quando são atingidos pontos de crescimento transicionais.

A disfunção familiar resulta de uma combinação de estresse e fracasso em se realinhar para lidar com a situação (Colapinto, 1991). Os estressores podem ser ambientais (um dos pais fica desempregado, a família se muda) ou

desenvolvimentais (um dos filhos atinge a adolescência, os pais se aposentam). O fracasso da família em lidar com a adversidade pode se dever a falhas em sua estrutura ou simplesmente à sua incapacidade de se ajustar a circunstâncias modificadas.

Nas famílias desligadas, as fronteiras são rígidas, e a família não consegue mobilizar apoio quando necessário. Pais desligados podem não perceber que um filho está deprimido ou com dificuldades na escola até o problema avançar muito. Nas famílias emaranhadas, por outro lado, as fronteiras são difusas, e os membros da família reagem exageradamente e se envolvem com os outros de maneira intrusiva. Pais emaranhados criam dificuldades ao impedir o desenvolvimento de formas mais maduras de comportamento em seus filhos e ao interferir em sua capacidade de resolver os próprios problemas.

Em seu livro sobre estudos de caso, *Family healing*, Minuchin e Nichols (1993) descrevem um exemplo comum de emaranhamento quando um pai se intromete para resolver pequenos desentendimentos entre os dois filhos – “como se os irmãos fossem Caim e Abel, e o ciúme fraterno pudesse levar ao assassinato” (Minuchin e Nichols, p. 149). O problema, evidentemente, é que, se os pais sempre interrompem as brigas dos filhos, estes não aprenderão a lutar as próprias batalhas.

Embora falemos sobre famílias emaranhadas e desligadas, é mais exato falar sobre subsistemas específicos como emaranhados ou desligados. De fato, emaranhamento e desligamento costumam ser recíprocos, de modo que, por exemplo, seja provável um pai excessivamente envolvido com seu trabalho se envolva menos com a família. Um padrão frequentemente encontrado é a síndrome mãe emaranhada/pai desligado – “o arranjo característico da família de classe média perturbada” (Minuchin e Nichols, 1993, p. 121).

Feministas têm criticado a noção de uma síndrome mãe emaranhada/pai desligado porque rejeitam a divisão estereotípica do trabalho (papel instrumental para o pai, papel expressivo para a mãe) e porque não querem culpar as mães por um arranjo que é culturalmente sancionado. Ambas as preocupações são válidas. Todavia, preconceito e acusações são devidos à aplicação insensível dessas idéias, não

inerentes às idéias em si. Relacionamentos tendenciosos, seja qual for a razão para eles, podem ser problemáticos, embora nenhum membro da família deva ser culpabilizado ou responsabilizado por corrigir, unilateralmente, o desequilíbrio.

As *hierarquias* podem ser frágeis e ineficazes ou rígidas e arbitrárias. No primeiro caso, membros mais jovens da família podem ficar desprotegidos pela ausência de orientação; no segundo, seu desenvolvimento como indivíduos autônomos pode ser prejudicado, ou lutas de poder podem ser o resultado. Exatamente como uma hierarquia funcional é necessária para a estabilidade de uma família sadia, a flexibilidade é necessária para que seus membros se adaptem a mudanças.

A expressão mais comum do medo da mudança é a *evitação do conflito*, quando os familiares evitam tratar de suas discordâncias para se protegerem da dor de se enfrentarem com verdades duras. As famílias desligadas evitam o conflito minimizando o contato; as famílias emaranhadas evitam o conflito negando diferenças, ou por meio de constantes alterações, o que lhes permite ventilar os sentimentos sem pressionar por mudanças ou resolver as questões.

Os terapeutas familiares estruturais utilizam alguns símbolos simples para diagramar problemas estruturais, e esses diagramas normalmente deixam claro quais mudanças são necessárias. A Figura 7.2 mostra alguns dos símbolos usados para diagramar estruturas familiares.

Um problema com frequência observado pelos terapeutas familiares é aquele em que os pais, incapazes de resolver conflitos entre si,

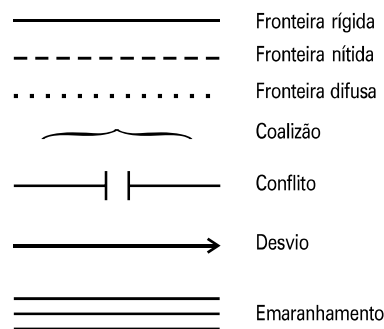


FIGURA 7.2 Símbolos de estrutura familiar.

desviam o foco de preocupação para a criança. Em vez de se preocuparem um com o outro, preocupam-se com a criança (ver Figura 7.3). Embora isso reduza a tensão no pai (P) e na mãe (M), vitimiza a criança (C) e, portanto, é disfuncional.

Um padrão alternativo, mas igualmente comum, é os pais continuarem a brigar por meio da criança. O pai diz que a mãe é permissiva demais; ela, que ele é rígido demais. Ele pode se afastar, fazendo com que ela critique sua falta de preocupação, o que, por sua vez, faz com que ele se afaste ainda mais. A mãe emaranhada reage às necessidades da criança com preocupação excessiva. O pai desligado tende a não reagir mesmo quando uma resposta é necessária. Ambos podem se criticar mutuamente, mas perpetuam o comportamento do outro com o seu próprio. O resultado é uma **coalizão geracional cruzada** entre a mãe e a criança, que exclui o pai (Figura 7.4).

Algumas famílias funcionam bem quando os filhos são pequenos, mas não conseguem se ajustar à necessidade de disciplina dos filhos que estão crescendo. Os filhos pequenos nas famílias emaranhadas (Figura 7.5) rece-

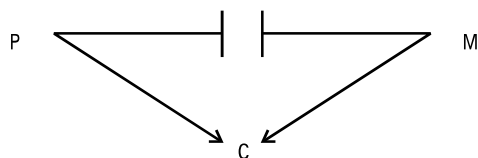


FIGURA 7.3 Designação de um bode expiatório para desviar o conflito.

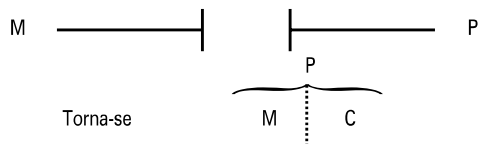


FIGURA 7.4 Coalizão mãe-criança.



FIGURA 7.5 Pais emaranhados com os filhos.

bem cuidados maravilhosos: os pais lhes dão muita atenção. Embora esses pais estejam cansados demais de cuidar dos filhos para terem muito tempo para si mesmos, o sistema pode ter um sucesso moderado. Entretanto, se esses pais dedicados não ensinarem os filhos a obedecer a regras e respeitar a autoridade, os filhos podem não estar preparados para negociar seu ingresso na escola. Acostumados a impor sua vontade, é possível que se tornem rebeldes e agitados. Algumas conseqüências possíveis dessa situação levam a família a tratamento. As crianças podem relutar ir à escola, e seus medos, ser reforçados por pais “compreensivos” que permitem que continuem em casa (Figura 7.6). Esse caso pode ser rotulado como fobia escolar e piorar se os pais permitirem que os filhos continuem em casa por mais de alguns dias.

Alternativamente, as crianças de tais famílias podem ir à escola, mas como não aprenderam a se acomodar aos outros, podem ser rejeitadas pelos colegas. Essas crianças muitas vezes ficam deprimidas e se retraem. Em outros casos, as crianças emaranhadas com os pais passam a ser um problema disciplinar na escola, e as autoridades escolares podem iniciar um aconselhamento.

Uma mudança importante na composição familiar que requer ajustamento estrutural ocorre quando cônjuges divorciados ou viúvos casam-se novamente. Essas “famílias misturadas” ou reajustam suas fronteiras ou logo passam a ter conflitos transicionais. Quando uma mulher se divorcia, ela e as crianças precisam primeiro aprender a se reajustar a uma estrutura que estabelece uma clara fronteira, separando os cônjuges divorciados, mas ainda permite contato entre o pai e os filhos; então, se ela casa novamente, a família precisa aprender a funcionar com um novo marido e padrastrado (Figura 7.7). Às vezes, é difícil para a mãe e os filhos permitirem que o padrastrado participe

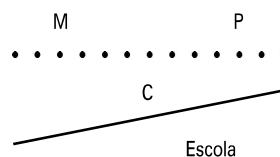


FIGURA 7.6 Fobia escolar.

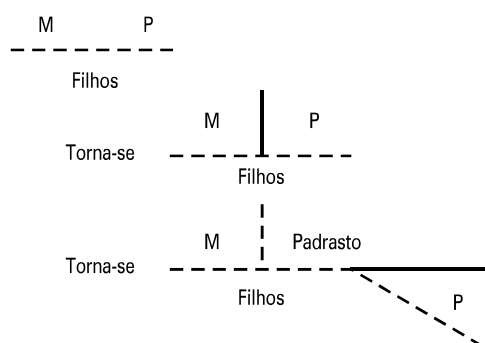


FIGURA 7.7 Divórcio e recasamento.

como parceiro no novo subsistema parental. A mãe e os filhos estabeleceram regras transacionais e aprenderam a se acomodar uns aos outros. O novo pai pode ser tratado como um estranho, de quem se espera que aprenda a maneira “certa” (costumeira) de fazer as coisas, e não como um novo parceiro que dará, assim como receberá, idéias sobre criação de filhos (Figura 7.8). Quanto mais a mãe e os filhos insistirem em manter seus padrões familiares sem incluir o padrasto, mais frustrado e zangado ele ficará. O resultado pode levar ao abuso da criança ou a brigas crônicas entre os pais. Quanto mais cedo essas famílias entrarem em tratamento, mais fácil será ajudá-las a se ajustarem à transição.

Aspecto importante dos problemas estruturais da família é que os sintomas de um de seus membros não apenas refletem os relacionamentos dessa pessoa com os outros, mas são também uma função de ainda outros relacionamentos na família. Se Johnny, de 16 anos, está deprimido, ajuda saber que está emaranhado com a mãe. Descobrir que ela exige dele uma obediência absoluta e se recusa a deixá-lo ter idéias próprias ou relacionamentos com pessoas de fora ajuda a explicar a sua depressão (Figura 7.9). Todavia, esta é uma visão apenas parcial do sistema familiar.

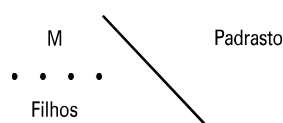


FIGURA 7.8 Fracasso em aceitar um padrasto.

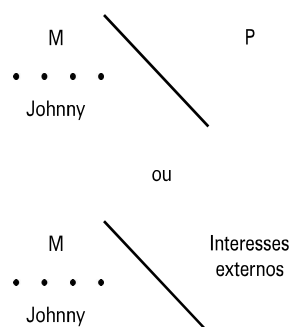


FIGURA 7.9 O emaranhamento de Johnny com a mãe e seu desligamento de interesses externos.

Por que a mãe está emaranhada com o filho? Talvez ela esteja desligada do marido. Talvez seja uma viúva que não encontrou novos amigos, um trabalho ou outros interesses. A melhor maneira de ajudar Johnny a resolver sua depressão talvez seja ajudar sua mãe a satisfazer as próprias necessidades de proximidade com o marido ou amigos.

Já que os problemas são uma função da estrutura familiar inteira, é importante incluir todo o grupo na avaliação. Contudo, às vezes, nem mesmo atender a família inteira é suficiente. A família nem sempre é o contexto completo ou mais relevante. A depressão de uma mãe poderia dever-se mais a relacionamentos no trabalho do que em casa. Os problemas escolares de um filho poderiam dever-se mais ao contexto estrutural escolar do que ao familiar. Nesses casos, o terapeuta familiar estrutural trabalha com o contexto mais relevante para amenizar os problemas apresentados.

Por fim, alguns problemas podem ser tratados como do indivíduo. Conforme Minuchin (1974, p. 9) escreveu, “A patologia pode estar dentro do paciente, em seu contexto social ou no *feedback* entre eles”. Alhures, Minuchin (Minuchin, Rosman e Baker, 1978, p. 91) se referiu ao perigo de “negar o indivíduo e entronizar o sistema”. Enquanto entrevista a família para ver como os pais lidam com os filhos, o terapeuta cuidadoso pode perceber que uma das crianças tem um problema neurológico ou uma incapacidade de aprendizagem. Esses problemas precisam ser identificados, e os encaminhamentos necessários, feitos. Habitualmente, quando uma criança tem dificuldades na escola, existe

um problema no contexto familiar ou escolar. Habitualmente, mas nem sempre.

OBJETIVOS DA TERAPIA

Os terapeutas familiares estruturais acreditam que os problemas são mantidos por uma organização familiar disfuncional. Portanto, a terapia visa a alterar a estrutura familiar, para que a família possa resolver seus problemas.

A idéia de que os problemas familiares estão inseridos em estruturas disfuncionais levou alguns a criticarem a terapia familiar estrutural como patologizante. Os críticos vêem os mapas estruturais de organizações disfuncionais como se retratassem um núcleo patológico nas famílias. Isso não é verdade. Os problemas estruturais em geral são vistos como fracasso em se adaptar a mudanças nas circunstâncias. Longe de ver as famílias como inerentemente falhas, o terapeuta estrutural vê o seu trabalho como ativador de estruturas adaptativas latentes que já fazem parte do repertório da família (Simon, 1995).

O terapeuta familiar estrutural reúne-se ao sistema familiar para ajudar seus membros a mudarem sua estrutura. Ao alterar fronteiras e realinhar sistemas, o terapeuta muda o comportamento e a experiência de cada membro da família. O terapeuta não resolve problemas: esta tarefa é da família. O terapeuta ajuda a modificar o funcionamento familiar de modo que os membros da família possam resolver seus problemas. Dessa maneira, a terapia familiar estrutural é como a psicoterapia dinâmica – a resolução do sintoma é buscada não como um fim em si mesma, mas como um resultado de uma mudança estrutural. O analista modifica a estrutura da mente do paciente; o terapeuta familiar estrutural modifica a estrutura da família do paciente.

Os objetivos para cada família são ditados pelos problemas que seus membros apresentam e pela natureza de sua disfunção estrutural. Embora cada família seja única, existem problemas comuns e objetivos estruturais típicos. De extrema importância entre os objetivos gerais para as famílias é a criação de uma estrutura hierárquica efetiva. Espera-se que os pais estejam no comando, que não se relacionem com os filhos como iguais. Outro objetivo

comum é ajudar os pais a funcionarem juntos como um subsistema coeso. Quando só existe um progenitor, ou quando há vários filhos, um ou mais dos filhos mais velhos pode ser incentivado a ser um assistente parental, mas as necessidades dessa criança também não podem ser negligenciadas.

Com famílias emaranhadas, o objetivo é diferenciar indivíduos e subsistemas, reforçando as fronteiras entre eles. Com famílias desligadas, o objetivo é aumentar a interação, tornando as fronteiras mais permeáveis.

CONDIÇÕES PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

A terapia estrutural muda o comportamento ao abrir padrões alternativos de interação, capazes de modificar a estrutura familiar. Não é uma questão de criar novas estruturas, e sim de ativar estruturas dormentes. Quando novos padrões transacionais se tornam regularmente repetidos e previsivelmente efetivos, estabilizam a estrutura nova e mais funcional.

O terapeuta produz mudança reunindo-se à família, sondando em busca de áreas de flexibilidade e, então, ativando alternativas estruturais dormentes. Este reunir-se leva o terapeuta para dentro da família; o *acomodar-se* ao seu estilo o torna influente, e manobras de *reestruturação* transformam a estrutura familiar. Se o terapeuta continuar um estranho, alguém de fora, ou usar intervenções demasiado distônicas, a família o rejeitará. Se o terapeuta participar demais da família ou usar intervenções demasiado sintônicas, a família assimilará as intervenções a padrões transacionais prévios. Em qualquer um dos casos, não haverá mudança estrutural.

Reunir-se e acomodar-se são considerados pré-requisitos para reestruturar. Para se reunir a uma família, o terapeuta precisa transmitir que aceita seus membros e respeita sua maneira de fazer as coisas. Minuchin (1974) comparava o terapeuta familiar a um antropólogo, que precisa primeiro se reunir a uma cultura para poder estudá-la.

Para se reunir à cultura de uma família, o terapeuta faz aberturas de acomodação – o que habitualmente fazemos sem pensar, embora nem sempre com sucesso. Se os pais buscam ajuda para os problemas de um filho, o tera-

peuta não começa pedindo a opinião da criança. Isso transmite falta de respeito pelos pais. Só depois de ter conseguido se reunir à família é proveitoso tentar reestruturá-la – as geralmente dramáticas confrontações que desafiam a família a mudar.

A primeira tarefa é compreender a visão que a família tem dos seus problemas. O terapeuta faz isso ao tentar compreender sua formulação no conteúdo que usam para explicá-la e nas seqüências com as quais a demonstram. Então, o terapeuta familiar *reenquadra* a formulação da família em uma formulação baseada no entendimento da estrutura familiar.

De fato, todas as psicoterapias utilizam o reenquadramento. Os pacientes, sejam indivíduos, sejam famílias, chegam com idéias próprias sobre a causa de seus problemas – idéias que não costumam ajudá-los a resolver seus problemas –, e o terapeuta lhes oferece uma idéia nova e potencialmente mais construtiva desses mesmos problemas. O que torna única a terapia familiar estrutural é que ela usa **encenações** nas sessões de terapia para fazer o reenquadramento acontecer. Esta é a condição indispensável para a terapia familiar estrutural: observar e modificar a estrutura das transações familiares no contexto imediato da sessão. O terapeuta estrutural trabalha com o que vê acontecer na sessão, não com o que os membros da família relatam.

Há dois tipos de dados ao vivo, dentro da sessão, em que a terapia familiar estrutural se concentra – *encenações* e *seqüências comportamentais espontâneas*. Uma encenação é quan-

do o terapeuta estimula a família a demonstrar como esta lida com um tipo particular de problema. Em geral, a encenação começa quando o terapeuta sugere que subgrupos específicos discutam um determinado problema. Conforme se faz isso, o terapeuta observa o processo familiar. Trabalhar com encenações requer três operações. Primeiro, o terapeuta define ou reconhece uma seqüência. Por exemplo, observa que, quando a mãe fala com a filha, elas conversam como iguais, e o irmão mais jovem é deixado de fora. Segundo, o terapeuta dirige uma encenação. Por exemplo, ele pode dizer à mãe: “Converse sobre isso com seus filhos”. Terceiro, e mais importante, o terapeuta precisa orientar a família a modificar a encenação. Se a mãe conversa com os filhos sem assumir responsabilidade por decisões importantes, o terapeuta deve orientá-la a assumir essa responsabilidade conforme a família continua a encenação. Todos os movimentos do terapeuta devem criar novas opções para a família, opções de interações mais produtivas.

Quando uma encenação se paralisa, o terapeuta pode intervir de duas formas: comentando o que deu errado, ou simplesmente estimulando-os a prosseguir. Por exemplo, se um pai responde à sugestão de conversar com a filha de 12 anos sobre como ela se sente reprimendo-a, o terapeuta poderia dizer ao pai: “Parabéns”. Pai: “O que você quer dizer?” Terapeuta: “Parabéns; você vence, ela perde”. Ou o terapeuta poderia, simplesmente, cutucar a transação, dizendo ao pai: “Muito bom, continue conversando, mas ajude-a a expressar mais

Os terapeutas estruturais utilizam encenações para observar e modificar padrões familiares problemáticos.



seus sentimentos. Ela ainda é uma menina, precisa da sua ajuda”.

Além de trabalhar com encenações, o terapeuta estrutural está atento a seqüências comportamentais espontâneas que ilustram a estrutura familiar. Criar uma encenação é como dirigir uma peça de teatro; trabalhar com seqüências espontâneas é como focalizar um refletor em uma ação que ocorre sem direção. Ao observar e modificar tais seqüências cedo na terapia, o terapeuta evita se atolar na maneira habitual e improdutiva da família de fazer as coisas. Lidar com comportamentos problemáticos assim que ocorrem permite ao terapeuta organizar a sessão, para sublinhar o processo e modificá-lo.

Um terapeuta experiente desenvolve palpites sobre a estrutura familiar antes mesmo da primeira entrevista. Por exemplo, se a família procura a clínica por causa de uma criança “hiperativa”, é possível ter algum palpite sobre a estrutura familiar e as seqüências que acontecerão quando a sessão começar, pois o comportamento “hiperativo” muitas vezes é uma função do emaranhamento da criança com a mãe. O relacionamento da mãe com a criança pode ser produto da falta de diferenciação hierárquica dentro da família; isto é, pais e filhos se relacionam entre si como iguais. Além disso, o emaranhamento da mãe com a criança “hiperativa” provavelmente será tanto um resultado quanto uma causa da distância emocional com o marido. Sabendo que este é um padrão comum, o terapeuta pode antecipar que a criança “hiperativa” começará a se comportar mal logo no início da primeira sessão, e que a mãe será incapaz de lidar com esse mau comportamento. Armado com este palpite informado, o terapeuta pode lançar luz sobre essa seqüência assim que ela ocorrer. Se a criança “hiperativa” começar a correr pela sala e a mãe protestar, mas não fizer nada de efetivo, o terapeuta poderia dizer: “Eu vejo que seu filho se sente à vontade para ignorar você”. Este desafio pode levar a mãe a se comportar de maneira mais competente.

TERAPIA

Avaliação

Uma avaliação estrutural baseia-se na suposição de que as dificuldades da família via de regra refletem problemas na maneira pela

qual ela está organizada. Supõe-se que, se a organização mudar, o problema também vai mudar. Talvez seja importante acrescentar que as dificuldades costumam refletir problemas na maneira pela qual a família *inteira* está organizada. Portanto, supõe-se que, se ocorrer uma mudança entre a mãe e a filha, as coisas também mudarão entre marido e mulher.

Os terapeutas estruturais fazem avaliações primeiro reunindo-se à família para criar uma aliança e, depois, pondo a família em movimento pelo uso de encenações, diálogos na sessão que permitem ao terapeuta observar como os membros da família realmente interagem.

Suponha, por exemplo, que uma jovem se queixa de uma indecisão obsessiva. Ao responder às perguntas do terapeuta durante um encontro inicial com a família, a jovem fica indecisa e olha de relance para o pai. Ele fala e esclarece o que ela não consegue. Agora a indecisão da filha pode ser ligada à prestimosidade do pai, o que sugere um padrão de emaranhamento. Quando o terapeuta pede aos pais que conversem sobre suas opiniões sobre os problemas da filha, eles têm dificuldade em falar sem discutir reativamente, e a discussão não segue adiante. Isso sugere desligamento entre os pais, o que pode se relacionar (como causa e efeito) ao emaranhamento entre o pai e a filha.

Observe como a avaliação estrutural se estende além do problema apresentado e passa a incluir a família inteira e – sejamos francos – a suposição de que as famílias com problemas geralmente apresentam algum tipo de problema estrutural subjacente. Entretanto, é importante notar que os terapeutas estruturais não fazem suposições sobre como as famílias *deveriam ser* organizadas. Famílias monoparentais podem ser perfeitamente funcionais, tanto quanto as famílias com mães e papais, ou, na verdade, qualquer outra variação familiar. É o fato de a família buscar terapia para um problema que foi incapaz de resolver o que dá ao terapeuta a licença de supor que algo, na maneira específica pela qual essa família está organizada, talvez não esteja dando certo para ela.

A melhor maneira de fazer uma avaliação é focalizar o problema apresentado e, então, explorar a resposta da família a ele. Considere o caso de uma menina de 13 anos cujos pais se queixam de que ela mente. A primeira pergunta poderia ser: “Para quem ela mente?” Diga-

mos que a resposta é “para ambos os pais”. A pergunta seguinte seria: “Quão bons são os pais em perceber quando a filha está mentindo?” Depois, menos inocentemente: “Qual dos dois percebe melhor quando a filha está mentindo?” Talvez seja a mãe. De fato, digamos que a mãe está obcecada por detectar as mentiras da filha – a maioria das quais tem a ver com buscar independência, de uma maneira que eleva a ansiedade da mãe. Assim, uma mãe preocupada e uma filha desobediente estão aprisionadas a uma luta a respeito de crescer que exclui o pai.

Levando adiante essa avaliação, o terapeuta estrutural exploraria o relacionamento entre os pais. A suposição, entretanto, não seria de que os problemas da filha são resultado dos problemas conjugais, mas simplesmente que o relacionamento mãe-filha poderia estar ligado ao relacionamento entre os pais. Talvez os pais tenham se dado bem até a primogênita entrar na adolescência, quando a mãe passou a se preocupar muito mais que o pai. Seja qual for o caso, a avaliação também envolveria conversar com os pais sobre como foi crescer na família de cada um, a fim de explorar como seus passados ajudaram a torná-los do jeito que são.

O Dr. Minuchin e colaboradores escreveram, recentemente, um livro em que o processo de avaliação é organizado em quatro etapas (Minuchin, Nichols e Lee, no prelo). A primeira etapa é fazer perguntas sobre o problema apresentado até os membros da família começarem a perceber que o problema vai além da pessoa que apresenta o sintoma e inclui a família toda. A segunda etapa é ajudar os membros da família a perceber como suas interações podem, inadvertidamente, estar perpetuando o problema. A terceira etapa é uma breve exploração do passado, focalizando como os adultos da família chegaram às perspectivas que agora influenciam suas interações problemáticas. A quarta etapa é explorar opções que os membros da família possam pôr em prática para interagir de maneiras mais produtivas, que criem uma mudança na estrutura familiar e ajudem a resolver a queixa apresentada.

Técnicas terapêuticas

Em *Families and family therapy*, Minuchin (1974) ensinou os terapeutas familiares a en-

xergarem aquilo para o qual estavam olhando. Através das lentes da teoria familiar estrutural, interações familiares previamente confusas entravam em foco de súbito. Onde outros viam apenas caos e crueldade, Minuchin via estrutura: famílias organizadas em subsistemas com fronteiras. Esse livro de imenso sucesso (mais de 200 mil cópias impressas) não só nos ensinou a enxergar *emaranhamento* e *desligamento*, como também nos deu a esperança de que mudar isso era apenas uma questão de *reunir-se a, encenar* e *desequilibrar*. Minuchin fez com que mudar famílias parecesse simples. Não é.

Quem observasse Minuchin trabalhando 10 ou 20 anos depois da publicação de *Families and family therapy* veria um terapeuta criativo ainda evoluindo, não alguém congelado no tempo no ano de 1974. Ainda haveria confrontações claras (“Quem é o xerife nesta família?”), mas haveria menos encenações, menos diálogos encenados e dirigidos. Ainda ouviríamos uma miscelânea tomada emprestada de Carl Whitaker (“Quando foi que você se divorciou da sua mulher e se casou com seu trabalho?”), Maurizio Andolfi (“Por que você não mija no tapete, também?”) e outros. Minuchin combina muitos pontos em seu trabalho. Para aqueles familiarizados com seu trabalho anterior, tudo isso levanta a pergunta: Minuchin ainda é um terapeuta familiar estrutural? A pergunta, evidentemente, é absurda; nós a levantamos para enfatizar um ponto: a terapia familiar estrutural não é um conjunto de técnicas – é uma maneira de olhar para as famílias.

No restante desta seção, apresentaremos o esboço clássico da técnica familiar estrutural, com o seguinte alerta: depois que o terapeuta dominar os aspectos básicos da teoria estrutural, precisa aprender a traduzir a abordagem de uma maneira que se adapte ao seu estilo pessoal.

Em *Families and family therapy*, Minuchin (1974) listou três fases que se sobrepõem no processo da terapia familiar estrutural. O terapeuta (1) se reúne à família em uma posição de liderança, (2) mapeia sua estrutura subjacente e (3) intervém para transformar essa estrutura. Este programa é simples, no sentido de que segue um plano claro, mas muito complicado devido à infinita variedade de padrões familiares.

Para serem efetivos, os movimentos do terapeuta não podem ser pré-planejados ou ensaiados. Bons terapeutas são mais do que técnicos. A estratégia da terapia, por outro lado, precisa ser organizada. Em geral, a terapia familiar estrutural segue estes sete passos:

1. União e acomodação
2. Encenação
3. Mapeamento estrutural
4. Focalização e modificação de interações
5. Criação de fronteiras
6. Desequilíbrio
7. Desafio de suposições improdutivas

União e acomodação

Já que a maioria das famílias tem padrões homeostáticos firmemente estabelecidos, a terapia familiar às vezes requer confrontação. Contudo, desafios ao estilo habitual da família serão descartados a menos que sejam feitos de uma posição respeitosa. As famílias, como você e eu, resistem às tentativas de mudança por parte de alguém que elas sentem que não as entende nem aceita.

Os pacientes individuais em geral entram em tratamento já predispostos a aceitar a autoridade do terapeuta. Ao buscar terapia, o indivíduo tacitamente reconhece uma necessidade de ajuda e uma disposição a confiar no terapeuta. Isso não acontece com as famílias.

O terapeuta familiar é um estranho importado. Afinal de contas, por que ela insistiu em conversar com toda a família? Os membros da família esperam ouvir que estão fazendo algo errado e estão preparados para se defender. A família, portanto, é um grupo de não-pacientes que se sentem ansiosos e expostos; eles estão determinados a resistir.

Primeiro o terapeuta precisa desarmar defesas e aliviar a ansiedade. Isso é feito pela criação de uma aliança de entendimento com cada membro da família. O terapeuta saúda cada pessoa pelo nome e faz algum tipo de contato amigável.

Essas saudações iniciais transmitem respeito, não só pelos indivíduos da família, mas também por sua estrutura hierárquica e organizacional. O terapeuta demonstra respeito pelos pais ao tomar sua autoridade como algo

garantido. Eles, não seus filhos, são solicitados primeiramente a descrever seus problemas. Se uma família elege uma pessoa para falar pelas outras, o terapeuta percebe, mas não contesta isso de início.

As crianças também têm preocupações e capacidades especiais. Elas devem ser saudadas gentilmente e questionadas com perguntas simples, concretas. “Oi, eu sou fulana de tal; qual é o seu nome? Oh, Shelly, é um nome muito bonito. Em que escola você estuda, Shelly?” Com crianças mais velhas, tente evitar as habituais perguntas fingidas dos adultos (“E o que você quer ser quando crescer?”). Tente algo mais inovador (como “O que você mais detesta na escola?”). As que quiserem ficar em silêncio devem ter “permissão” para isso. Elas ficarão caladas, de qualquer maneira, mas o terapeuta que aceita sua reticência terá dado um passo importante no sentido de mantê-las envolvidas. “E o que você pensa sobre esse problema?” (Silêncio total.) “Entendo, você não está com vontade de dizer nada agora? Tudo bem, talvez você queira dizer alguma coisa mais tarde.”

O fracasso em se reunir e se acomodar à família produz resistência, e a culpa geralmente recai sobre a família. Pode ser confortador culpar os clientes quando as coisas não vão bem, mas isso não ajuda em nada. Podemos chamar os membros da família de “negativos”, “rebel-des”, “resistentes” ou “desafiadores”, e vê-los como “desmotivados”, mas ainda é mais útil fazer um esforço extra para conectar-se com eles.

É particularmente importante reunir-se aos membros fortes da família e também aos que estão zangados. Devemos fazer um esforço especial para aceitar o ponto de vista do pai que acha que terapia é bobagem ou do adolescente que se sente um criminoso acusado. Também é importante reconectar-se com essas pessoas a intervalos freqüentes, particularmente quando as coisas começam a esquentar.

Um bom começo é saudar a família e depois perguntar a opinião de cada pessoa sobre o problema. Ouça cuidadosamente e reconheça a posição de cada um, devolvendo o que você ouviu. “Entendo, Sra. Jones, a senhora acha que a Sally deve estar deprimida por alguma coisa que aconteceu na escola.” “Então, Sr. Jones, você vê algumas coisas que a sua esposa também vê, mas não está convencido de que este é um problema sério. É isso?”

Encenação

A estrutura familiar se manifesta na maneira pela qual os membros da família interagem. Ela nem sempre pode ser inferida a partir de suas descrições. Portanto, fazer perguntas como: “Quem está no comando?” ou “Vocês dois concordam?” tende a ser improdutivo. As famílias geralmente se descrevem mais como acham que deveriam ser do que como são.

Fazer com que os membros da família conversem entre si contraria suas expectativas. Eles esperam apresentar seu caso para um especialista e então receber uma orientação sobre o que fazer. Se solicitados a discutir alguma coisa na sessão, eles dirão: “Nós já falamos sobre isso muitas vezes” ou “Não vai adiantar nada, ele (ou ela) não escuta” ou “Mas o especialista não deveria ser *você* ?”

Se o terapeuta começar dando a cada pessoa a chance de falar, habitualmente alguém dirá algo sobre outro que pode ser um trampolim para uma encenação. Quando, por exemplo, um dos pais diz que o outro é rígido demais, o terapeuta pode dar início a uma encenação dizendo: “Ela diz que você é rígido demais; você pode responder a ela?” Escolher um ponto específico para resposta é mais efetivo que pedidos vagos, como: “Por que vocês dois não falam sobre isso?”

Depois que a encenação começar, o terapeuta pode descobrir muitas coisas sobre a estrutura da família. Por quanto tempo duas pessoas podem conversar sem serem interrompidas – isto é, quão clara é a fronteira? Alguém ataca, o outro defende? Quem é central, quem é periférico? Os pais envolvem os filhos em suas discussões – isto é, eles estão emaranhados?

As famílias demonstram emaranhamento quando se interrompem com frequência, falam por outros membros, fazem coisas para os filhos que estes podem fazer sozinhos ou brigam constantemente. Nas famílias desligadas podemos ver um marido sentado impassivelmente enquanto a mulher chora, uma total ausência de conflito, uma surpreendente ignorância de informações importantes sobre os filhos ou falta de consideração pelos interesses dos outros.

Se, assim que a primeira sessão começar, as crianças passarem a correr pela sala enquanto os pais protestam ineficazmente, o terapeuta

não precisa ouvir descrições do que acontece em casa para perceber a incompetência executiva. Se mãe e filha se enfurecem e vociferam entre si enquanto o pai continua sentado silenciosamente no canto, não é necessário perguntar quão envolvido ele é em casa. De fato, perguntar pode transmitir um quadro menos exato do que aquele revelado espontaneamente.

Mapeamento estrutural

As famílias habitualmente concebem os problemas como localizados no paciente identificado e determinados por acontecimentos do passado. Esperam que o terapeuta mude o paciente identificado – com o mínimo possível de alteração na família. Os terapeutas familiares consideram os sintomas do paciente identificado como uma expressão dos padrões disfuncionais que afetam toda a família. Uma avaliação estrutural amplia o problema além dos indivíduos para o sistema familiar e transfere o foco de acontecimentos isolados do passado para as transações que estão acontecendo no presente.

Até os terapeutas familiares muitas vezes categorizam as famílias com construtos que se aplicam mais a indivíduos que a sistemas. “O problema nesta família é que a mãe sufoca os filhos” ou “Esses filhos são desafiadores” ou “Ele não se envolve”. Os terapeutas familiares estruturais tentam avaliar a inter-relação entre todos os membros da família. Com os conceitos de fronteiras e subsistemas, a estrutura de todo o sistema é descrita de maneira que aponta para mudanças desejáveis.

Avaliações preliminares baseiam-se em interações ocorridas na primeira sessão. Nas sessões posteriores, essas formulações são aperfeiçoadas e revisadas. Embora haja certo perigo de forçar as famílias a se encaixarem em categorias quando as aplicamos precocemente, o maior perigo é esperar demais. Costumamos enxergar as pessoas mais claramente durante o contato inicial. Mais tarde, quando passamos a conhecê-las melhor, nós nos acostumamos às suas idiossincrasias e logo deixamos de percebê-las.

As famílias rapidamente *induzem* o terapeuta à sua cultura. Uma família que, de início, parece ser caótica e emaranhada, logo pas-

sa a ser apenas a conhecida família Jones. Por essa razão, é essencial desenvolver hipóteses estruturais relativamente cedo no processo.

De fato, convém refletir e palpar sobre a estrutura da família antes mesmo da primeira sessão. Isso dá início a um processo de pensamento ativo e monta o cenário para observar a família. Por exemplo, suponha que você vai atender uma família formada por uma mãe, uma filha de 16 anos e um padrasto. A mãe telefonou para se queixar do mau comportamento da filha. Qual você imagina que poderia ser a estrutura e como pode testar a sua hipótese? Um bom palpite seria que a mãe e a filha estão emaranhadas, excluindo o padrasto. Isso pode ser testado ao se verificar se mãe e filha conversam principalmente uma sobre a outra na sessão – quer positiva, quer negativamente. O desligamento do padrasto poderá ser confirmado se ele e a esposa não conseguirem conversar sem a intrusão da filha.

Avaliações estruturais levam em conta tanto o problema que a família apresenta quanto a dinâmica estrutural revelada. Incluem todos os membros da família. Neste caso, saber que mãe e filha estão emaranhadas não é suficiente: você também precisa saber o papel que o padrasto desempenha. Se ele é razoavelmente próximo da esposa, mas distante da filha, encontrar atividades mutuamente prazerosas para padrasto e enteada ajudará a torná-la mais independente da mãe. Por outro lado, se a proximidade da mãe em relação à filha parecer uma função de sua distância do marido, então o par conjugal poderia ser o foco mais produtivo.

Sem uma formulação e um plano estruturais, o terapeuta fica defensivo e passivo. Em vez de saber aonde ir e mover-se deliberadamente, ele se recosta e tenta lidar com a família, ou apagar incêndios e ajudá-los a enfrentar uma sucessão de incidentes. Um conhecimento consistente da estrutura da família e o foco em uma ou duas mudanças estruturais ajuda o terapeuta a enxergar por trás das várias questões de conteúdo que os membros da família trazem à baila.

Focalização e modificação de interações

Quando as famílias começam a interagir, surgem transações problemáticas. Reconhecer

suas implicações estruturais exige um foco no processo, não no conteúdo. Nada sobre estrutura é revelado ao se ouvir quem é a favor de castigos ou quem fala bem de quem. A estrutura familiar é revelada por quem diz o que a quem e de que maneira.

Talvez uma esposa se queixe: “Nós temos um problema de comunicação. Meu marido não fala comigo, ele nunca expressa seus sentimentos”. O terapeuta então inicia uma encenação para ver o que realmente acontece. “A sua mulher diz que vocês têm um problema de comunicação; você pode responder a isso? Fale com ela.” Se, quando eles conversarem, a mulher se tornar dominadora e crítica e o marido passar a falar cada vez menos, o terapeuta verá o que está errado: o problema não é que ele não fala, o que é uma explicação linear. O problema também não é que ela importuna, também uma explicação linear. O problema é que, quanto mais ela importuna, mais ele se afasta, e quanto mais ele se afasta, mais ela importuna.

O truque é modificar esse padrão. Isso pode requerer uma intervenção enérgica, ou o que os terapeutas estruturais chamam de **intensidade**.

Minuchin fala com as famílias com um impacto dramático e convincente. Ele regula a intensidade de suas mensagens para exceder o limiar que os membros da família têm para não escutarem desafios à sua maneira de perceber a realidade. Quando Minuchin fala, as famílias escutam.

Minuchin é enérgico, mas a intensidade não é meramente uma função da personalidade; ela reflete clareza de propósito. O conhecimento da estrutura familiar e o comprometimento em ajudar as famílias a mudar possibilitam poderosas intervenções.

Os terapeutas estruturais atingem intensidade pela regulação seletiva de afeto, repetição e duração. Tom, volume, ritmo e escolha de palavras são usados para aumentar a intensidade afetiva das declarações. Ajuda se você souber o que quer dizer. Aqui vai um exemplo de uma declaração sem energia: “As pessoas sempre se preocupam consigo mesmas, como que vendo a si próprias no centro das atenções e só procurando aquilo que lhes interessa. Não seria mais legal, para variar, se todo o mundo começasse a pensar sobre o que pode fazer pelos outros?” Compare isso com: “Não per-

gunte o que o seu país pode fazer por você – pergunte o que você pode fazer por seu país”. As palavras de John Kennedy tiveram impacto porque foram bem escolhidas e claramente enunciadas. Os terapeutas familiares não precisam discursar, mas, ocasionalmente, precisam falar com energia para se fazer entender.

A intensidade afetiva não é apenas uma questão de enunciado claro. Você tem de saber como e quando ser provocativo. Por exemplo, Mike Nichols trabalhou com uma família em que o paciente identificado era uma mulher de 29 anos com anorexia. Embora a família mantivesse uma fachada de união, era rigidamente estruturada; a mãe e a filha anoréxica eram emaranhadas, enquanto o pai era excluído. Nessa família, o pai era o único a expressar raiva abertamente, e esta constituía parte do motivo de sua exclusão. A filha tinha medo da raiva dele, o que ela reconhecia francamente. O que estava menos claro, contudo, era que a mãe a ensinara veladamente a evitar o pai, porque ela, a mãe, não conseguia lidar com a raiva dele. Conseqüentemente, a filha cresceu temendo o pai e os homens em geral.

A certo ponto, o pai falou sobre como se sentia isolado da filha; ele disse que achava que era por ela ter medo da raiva dele. A filha concordou, “É culpa dele, sim”. O terapeuta perguntou à mãe o que ela achava, e a mãe respondeu: “Não é culpa *dele*”. O terapeuta falou: “Você está certa”. Ela continuou, negando seus reais sentimentos para evitar conflito: “Não é culpa de ninguém”. O terapeuta respondeu de uma maneira que chamou a atenção dela: “Isso não é verdade”. Surpresa, ela perguntou o que ele queria dizer. “A culpa é *sua*”, respondeu ele.

Este nível de intensidade era necessário para interromper um padrão rígido de evitação de conflito que mantinha uma aliança destrutiva entre mãe e filha. O conteúdo – quem realmente está com medo da raiva – é menos importante que o objetivo estrutural: libertar a filha de sua posição de envolvimento excessivo com a mãe.

Os terapeutas, com muita freqüência, diluem suas intervenções ao qualificar exageradamente, pedir desculpas ou divagar. Isso não é um problema tão sério na terapia individual, em que via de regra é melhor eliciar interpretações do paciente. As famílias são mais como

a mula proverbial do fazendeiro – às vezes é preciso bater na cabeça delas para obter a sua atenção.

Intensidade também pode ser obtida com o aumento da duração de uma seqüência além do ponto em que a homeostase se reinstala. Um exemplo comum é o manejo de explosões de raiva. Explosões de raiva são mantidas por pais que cedem. A maioria dos pais *tenta* não ceder; eles só não tentam o tempo suficiente. Recentemente, uma menina de 4 anos começou a berrar como louca quando a irmã saiu da sala. Ela queria ir com a irmã. Seus berros eram quase insuportáveis, e os pais estavam prontos para recuar. Entretanto, o terapeuta os exortou a não se darem por vencidos e sugeriu que a segurassem até ela se acalmar, “para lhe mostrar quem mandava”. Ela berrou por 30 minutos! Todo o mundo na sala estava em frangalhos. Contudo, a garotinha, finalmente, percebeu que desta vez não conseguiria impor sua vontade, de modo que se acalmou. Depois, os pais foram capazes de empregar a mesma intensidade de duração para fazê-la abandonar esse hábito altamente destrutivo.

Às vezes, intensidade requer repetição de um tema em uma variedade de contextos. Pais infantilizadores precisam ouvir que não devem pendurar o casaco da filha, não devem falar por ela, não devem levá-la ao banheiro e não devem fazer muitas outras coisas que ela é capaz de fazer por si mesma.

O que estamos chamando de “intensidade” pode parecer a alguns excessivamente agressivo. Embora não se possa negar que Minuchin e seus seguidores tendem a ser intervencionistas, o objetivo da intensidade não é intimidar as pessoas, e sim empurrá-las além do ponto em que desistem de alcançar-se mutuamente. Uma estratégia alternativa para as interações que estão em um impasse é o uso da **empatia**, para ajudar os membros da família a irem além da superfície de suas alterações defensivas.

Se, por exemplo, os pais de uma criança desobediente estão aprisionados em um ciclo de brigas improdutivas, em que a mãe ataca o pai por não se envolver, e ele responde com desculpas, o terapeuta pode usar intensidade para incentivá-los a planejar como lidar com o comportamento do filho. Em outra alternativa, o terapeuta pode interromper sua discus-

são e, por meio da empatia, conversar com um de cada vez sobre como se sentem. A mulher que só demonstra raiva pode estar encobrindo a mágoa e os anseios que sente. O marido que não se envolve nem briga quando se sente atacado pode estar irritado demais com a raiva da mulher para perceber que ela precisa dele. Quando essas emoções mais genuínas forem articuladas, podem servir de base para os clientes se reconectarem de maneira menos defensiva.

Dar forma à competência é outro método para modificar interações e é uma marca registrada da terapia familiar estrutural. A intensidade geralmente é usada para bloquear o fluxo de interações. Criar competência é como dar uma cutucada a fim de mudar a direção do fluxo. Ao salientar e dar forma aos aspectos positivos, o terapeuta estrutural ajuda os membros da família a adotarem alternativas funcionais que já fazem parte de seu repertório.

Um erro comum cometido por terapeutas inexperientes é tentar desenvolver um desempenho competente apenas com o apontamento dos erros. Isso focaliza o conteúdo sem levar em conta o processo. Dizer aos pais que eles fazem algo errado ou sugerir que façam algo diferente tem o efeito de criticar sua competência. Apesar das boas intenções, ainda é humilhante. Embora esse tipo de intervenção não possa ser de todo evitado, uma abordagem mais efetiva é apontar o que eles estão fazendo certo.

Mesmo quando as pessoas cometem muitos erros, normalmente é possível escolher algo que fazem bem. Um senso de momento certo ajuda. Por exemplo, em uma grande família caótica, os pais eram muito ineficazes no controle dos filhos. Em certo momento, o terapeuta se voltou para a mãe e disse: “Está muito barulhento aqui; você poderia acalmar as crianças?” Sabendo que era difícil para ela controlar os filhos, o terapeuta estava pronto a comentar imediatamente qualquer passo na direção de um manejo efetivo. A mãe teve de gritar “Quiéto!” algumas vezes antes que as crianças parassem momentaneamente o que estavam fazendo. Rapidamente – antes que as crianças retomassem o mau comportamento –, o terapeuta cumprimentou a mãe por “amar os filhos o suficiente para ser firme com eles”. Assim, a mensagem transmitida foi: “Você é uma pessoa competente, você sabe como ser firme”.

Se o terapeuta tivesse esperado que o caos recomeçasse antes de dizer à mãe que deveria ser firme, a mensagem seria: “Você é incompetente”.

Sempre que possível, os terapeutas estruturais evitam fazer o que os membros da família são capazes de fazer sozinhos. Aqui, também, a mensagem é: “Vocês são competentes, conseguem fazer isso”. Alguns terapeutas justificam o assumir funções da família chamando isto de “modelagem”. Independentemente de como for chamado, tem o impacto de dizer aos membros da família que são inadequados. Recentemente, uma jovem mãe confessou que não soubera como dizer aos filhos que iam falar com um terapeuta de família e, então, dissera simplesmente que iam dar uma volta. Querendo ajudar, o terapeuta então explicou às crianças que “A mamãe me disse que há alguns problemas na família, de modo que nós todos estamos aqui para conversar sobre as coisas a fim de ver se podemos melhorá-las”. Esta adorável explicação diz às crianças por que elas vieram, mas confirma a mãe como incompetente para fazê-lo. Se, em vez disso, o terapeuta tivesse sugerido à mãe: “Você gostaria de dizer a eles agora?” Então a mãe, não o terapeuta, teria de se comportar como uma mãe capaz.

Criação de fronteiras

A dinâmica familiar disfuncional é produto de fronteiras demasiado rígidas ou difusas. Os terapeutas estruturais intervêm para realinhar as fronteiras, aumentando ou a proximidade ou a distância entre os subsistemas familiares.

Nas famílias emaranhadas, as intervenções do terapeuta têm o objetivo de fortalecer as fronteiras entre subsistemas e aumentar a independência dos indivíduos. Os membros da família são exortados a falar por si mesmos; interrupções são bloqueadas, e díades são ajudadas a concluir suas conversas sem intrusão de outros. O terapeuta que quer apoiar o subsistema dos irmãos e protegê-lo da intrusão parental desnecessária poderia dizer: “Susie e Sean, conversem sobre isso, e todos os outros vão escutar atentamente”. Se os filhos interrompem os pais com frequência, o terapeuta

poderia desafiar os pais a reforçarem a fronteira hierárquica dizendo: “Por que vocês não dizem a eles para caírem fora, de modo que vocês dois, adultos, possam resolver isso?”

Embora a terapia familiar estrutural comece com o grupo familiar total, sessões subsequentes podem ser realizadas com indivíduos ou subgrupos a fim de reforçar as fronteiras que os cercam. Um adolescente excessivamente protegido pela mãe é apoiado como pessoa independente ao participar de sessões individuais. Pais tão emaranhados com os filhos que nunca conseguem conversar em particular podem começar a aprender a fazê-lo em sessões terapêuticas só para eles.

Quando uma mulher de 40 anos telefonou para a clínica querendo ajuda por estar deprimida, foi solicitada a comparecer com o restante da família. Logo ficou aparente que essa mulher estava sobrecarregada por seus quatro filhos e recebia pouco apoio do marido. A estratégia do terapeuta foi reforçar a fronteira entre a mãe e os filhos e ajudar os pais a se aproximarem. Fez-se isso em estágios. Primeiro, o terapeuta se reuniu com a filha mais velha, de 16 anos, e apoiou sua competência como uma potencial ajudante da mãe. Depois disso, a menina conseguiu assumir uma série de responsabilidades pelos irmãos menores, tanto nas sessões como em casa.

Liberados das preocupações com os filhos, os pais agora se deparavam com a oportunidade de conversar mais. Contudo, tinham pouco a dizer. Isso não resultava de um conflito oculto, mas refletia o casamento de duas pessoas relativamente não-verbais. Após várias sessões em que tentou fazer com que o par conversasse, o terapeuta percebeu que, apesar de algumas pessoas gostarem de conversar, outras não gostam. Então, para fortalecer o vínculo entre o casal, o terapeuta pediu que planejassem uma viagem especial juntos. Eles escolheram fazer um passeio de barco em um lago próximo. Quando voltaram para a sessão seguinte, estavam radiantes. Tinham se divertido muito. Depois, decidiram passar algum tempo sozinhos toda a semana.

Famílias desligadas tendem a evitar conflitos e, assim, minimizam a interação. O terapeuta estrutural intervém para desafiar a evitação do conflito e bloquear os desvios, a fim de ajudar os membros desligados a aumentarem

o contato entre si. Sem agir como juiz ou árbitro, o terapeuta encoraja os membros da família a se enfrentarem honestamente e a lidarem com suas dificuldades. Quando terapeutas inexperientes vêem desligamento, tendem a pensar em maneiras de aumentar interações positivas. De fato, o desligamento costuma ser uma maneira de evitar brigas. Portanto, cônjuges isolados um do outro costumam precisar brigar antes de poderem se tornar mais amorosos.

A maioria das pessoas subestima o grau de influência de seu comportamento sobre as pessoas que as cercam. Isso vale especialmente nas famílias desligadas. Os problemas, via de regra, são vistos como o resultado do que outra pessoa está fazendo, e as soluções requerem que os outros mudem. Há queixas típicas. “Nós temos um problema de comunicação; ele nunca me diz o que sente.” “Ele só se importa com aquele maldito trabalho dele.”

“A nossa vida sexual é péssima – a minha mulher é frígida.” “Ninguém consegue conversar com ela. Ela fica o tempo todo se queixando das crianças.” Cada uma dessas afirmações sugere que o poder de mudança está unicamente na outra pessoa. Esta é a visão quase universalmente percebida da causalidade linear.

Embora a maioria das pessoas veja as coisas dessa maneira, os terapeutas familiares percebem a circularidade inerente da interação sistêmica. Ele não diz à esposa o que sente porque ela reclama e critica, e ela reclama e critica porque ele não diz a ela o que sente.

Os terapeutas estruturais levam as discussões familiares da perspectiva linear para a perspectiva circular ao enfatizar a complementaridade. À mãe que se queixa de que o filho é desobediente se ensina a refletir sobre o que estará fazendo para desencadear ou manter o mau comportamento dele. A pessoa que pede mudanças precisa aprender a mudar seu jeito de tentar obter isso. A mulher que importuna o marido para que passe mais tempo com ela precisa aprender a tornar mais atraente o maior envolvimento. O marido que se queixa de que a mulher jamais o escuta precisa escutá-la mais, antes de que ela se disponha à reciprocidade.

Minuchin enfatiza a complementaridade ao pedir aos membros da família que ajudem uns aos outros a mudar. Quando forem relatadas mudanças positivas, ele provavelmente

cumprimentará os familiares, sublinhando a inter-relação na família.

Desequilíbrio

Ao criar fronteiras, o terapeuta quer realinhar relacionamentos *entre* subsistemas. Ao criar desequilíbrio, quer mudar o relacionamento *dentro* de um subsistema. O que geralmente mantém as famílias em um impasse é que familiares em conflito se fiscalizam e se equilibram e, em resultado, permanecem congelados na inação. Ao criar desequilíbrio, o terapeuta se reúne a um indivíduo ou subsistema e o apóia, à custa de outros.

Tomar partido – vamos dizer o que isto realmente é – parece uma violação do sagrado cânone terapêutico de neutralidade. Entretanto, o terapeuta toma partido para desequilibrar e realinhar o sistema, não porque é juiz de quem está certo ou errado. No final das contas, o equilíbrio e a justiça prevalecem porque o terapeuta toma partido de vários membros da família, um de cada vez.

Estudo de caso

Quando a família MacLean buscou ajuda por causa de uma criança “incontrolável”, um terror que fora expulso de duas escolas, o Dr. Minuchin descobriu uma cisão encoberta entre os pais, mantida em equilíbrio por não ser mencionada. O mau comportamento do menino de 10 anos era muito visível: o pai teve de arrastá-lo, com ele chutando e berrando, para dentro do consultório. Enquanto isso, seu irmão de 7 anos permanecia sentado tranqüilamente, sorrindo de forma encantadora – o bom menino.

A fim de ampliar o foco do “filho impossível” para questões de controle e cooperação parental, Minuchin perguntou sobre o filho de 7 anos, Kevin, o qual se comportava mal de forma velada. Ele urinava no chão do banheiro. Segundo o pai, Kevin urinava no chão do banheiro por “desatenção”. A mãe riu quando Minuchin comentou: “Ninguém pode ter uma mira assim tão ruim”.

Minuchin falou com o menino sobre como os lobos marcam seu território e sugeriu que expandisse seu território urinando nos quatro cantos da sala de estar da família.

Minuchin: Vocês têm um cachorro?

Kevin: Não.

Minuchin: Oh, então você é o cachorro da família.

No processo de discutir sobre o menino que urinava – e a reação dos pais –, Minuchin dramatizou como os pais se polarizavam.

Minuchin: Por que ele faria uma coisa dessas?

Pai: Eu não sei se ele fez de propósito.

Minuchin: Talvez ele estivesse em transe?

Pai: Não, acho que ele foi descuidado.

Minuchin: A mira dele é realmente terrível.

O pai descreveu o comportamento do filho como acidental; a mãe o considerava desafiador. Uma das razões pelas quais os pais passam a ser controlados pelos filhos pequenos é que evitam confrontar suas diferenças. Diferenças são normais, mas tornam-se prejudiciais quando um dos pais solapa o manejo do outro em relação aos filhos. (É uma vingança covarde por mágoas não-resolvidas.)

A pressão gentil, mas insistente, de Minuchin sobre o casal para que conversassem sobre como reagiam, sem mudar o foco para como os filhos se comportavam, fez com que eles desenterrassem ressentimentos muito antigos, mas raramente mencionados.

Mãe: Bob desculpa o comportamento das crianças porque não quer se envolver e me ajudar a encontrar uma solução para o problema.

Pai: Sim, mas quando eu tentei ajudar, você sempre me criticou. Então, depois de um tempo, eu desisti.

Como uma fotografia imersa em uma bacia de revelação, o conflito dos cônjuges tornara-se visível. Minuchin protegeu os pais da vergonha (e os filhos de ficarem sobrecarregados) pedindo às crianças que saíssem da sala. Sem a preocupação de agirem como pais, os cônjuges puderam se enfrentar, homem e mulher – e conversar sobre suas mágoas e ressentimentos. O que apareceu foi uma triste história de desligamento solitário.

Minuchin: Vocês dois têm áreas em que concordam?

Ele disse que sim; ela, que não. Ele era um minimizador; ela, uma crítica.

Minuchin: Quando foi que você se divorciou de Bob e se casou com as crianças?

Ela se manteve em silêncio; ele olhou para o teto. Ela disse, baixinho: “Provavelmente dez anos atrás”.

O que se seguiu foi uma história dolorosa, mas conhecida, de como um casamento pode afundar na paternidade e em seus conflitos. O conflito jamais era resolvido porque nunca aflorava à superfície. Assim, a brecha nunca se fechava.

Com a ajuda de Minuchin, o casal se revezou falando sobre seu sofrimento – e aprendeu a escutar. Ao criar desequilíbrio, Minuchin criou uma imensa pressão para ajudar esse casal a resolver suas diferenças, se abrir um para o outro, lutar por aquilo que queriam e, finalmente, começar a se aproximar – como marido e mulher, e como pais.

Criar desequilíbrio é parte de uma luta pela mudança que às vezes assume a aparência de um combate. Quando o terapeuta diz a um pai que ele não está fazendo o suficiente ou a uma mãe que ela está excluindo o marido, pode parecer que o combate é entre o terapeuta e a família, que ele os está atacando. Contudo, o combate real é entre eles e o medo – o medo de mudar.

Desafiar suposições improdutivas

Embora a terapia familiar estrutural não seja uma abordagem primariamente cognitiva, seus praticantes às vezes desafiam a maneira pela qual os membros da família vêem as coisas. Mudar a maneira de eles se relacionarem oferece visões alternativas de sua situação. O inverso é verdadeiro: mudar a maneira pela qual eles vêem sua situação lhes permite mudar sua maneira de se relacionar.

Quando os pais de Cassie, de 6 anos, se queixam de seu comportamento, dizem que ela é “hipersensível”, uma “criança nervosa”. Esses rótulos têm um poder tremendo. O comportamento de uma criança é “mau comportamento” ou é um sintoma de “nervosismo”? É “desobediência” ou um “pedido de ajuda”? A criança é louca ou má. Quem é responsável? O que significa um nome? Muita coisa.

Às vezes, o terapeuta familiar estrutural age como professor, dando informações e conselhos, em geral sobre questões estruturais. Isso provavelmente será uma manobra reestruturadora a se realizar de maneira que minimize a resistência. O terapeuta faz isso primeiro com um “afago” e depois um “pontapé”. Se ele está lidando com uma família em que a mãe fala pelos filhos, ele poderia dizer a ela “Você é muito prestativa” (afago), mas aos filhos “A mamãe tira a voz de vocês. Vocês são capazes de falar por si mesmos” (pontapé). Assim, a mãe é definida como prestativa, mas intrusiva (um afago e um pontapé).

Os terapeutas estruturais também utilizam ficções pragmáticas para dar aos membros da família um novo enquadre para experienciar. O objetivo não é educar ou enganar, mas oferecer um pronunciamento que ajude a família a mudar. Por exemplo, dizer aos filhos que eles

se comportam como se fossem menores do que são é uma maneira muito eficaz de fazer com que mudem. “Quantos anos você tem?” “Sete.” “Oh, eu pensei que você fosse mais jovem; a maioria das crianças de 7 anos não precisa mais que a mamãe entre com elas na escola.”

Paradoxos são construções cognitivas que frustram ou confundem os membros da família, levando-os a buscar alternativas. Minuchin usa pouco o paradoxo, mas às vezes ele ajuda a expressar ceticismo sobre as pessoas mudarem. Embora isso possa ter o efeito paradoxal de desafiá-las a mudar para provar que você estava errado, não é tanto um estratagema esperto quanto é uma declaração benigna da verdade. A maioria das pessoas *não* muda – elas esperam que os outros façam isso.

AVALIANDO A TEORIA E OS RESULTADOS DA TERAPIA

Em *Families of the slums*, Minuchin e colaboradores (1967) descreveram as características estruturais de famílias de baixo nível socioeconômico e demonstraram a efetividade da terapia familiar com essa população. Antes do tratamento, as mães das famílias dos pacientes eram ou muito ou pouco controladoras; em ambos os casos, os filhos eram mais agitados que os das famílias com controle. Após o tratamento, as mães usavam menos controle coercitivo, mas eram mais claras e mais firmes. Dentre as famílias 7 de 11 foram avaliadas como se houvessem obtido melhora depois de seis meses a um ano de terapia familiar. Embora não tenha sido usado nenhum grupo-controle, os autores compararam seus resultados favoravelmente ao índice habitual de 50% de sucesso terapêutico na Wiltwyck. (Nenhuma das famílias avaliadas como desligadas melhorou.)

Decididamente, a defesa empírica mais sólida da terapia familiar estrutural vem de uma série de estudos com crianças psicossomáticas e adultos drogaditos. Estudos que demonstram a efetividade da terapia com crianças gravemente psicossomáticas são convincentes por causa das medidas fisiológicas empregadas, e dramáticos devido ao risco de morte inerente aos problemas. Minuchin, Rosman e Baker (1978) relatam um estudo que demonstra com clareza como o conflito familiar pode

precipitar quadros de cetoacidose em crianças com diabetes que descompensa por fatores psicossomáticos. Em entrevistas iniciais, os pais discutiram problemas familiares na ausência dos filhos. Os cônjuges normais apresentaram os níveis mais elevados de confrontação, enquanto os cônjuges psicossomáticos exibiram uma grande variedade de manobras para evitar conflitos. A seguir, um terapeuta pressionava os pais a aumentarem o nível de seu conflito, enquanto os filhos observavam por trás de um espelho unidirecional. Conforme os pais discutiam, somente as crianças psicossomáticas pareciam de fato perturbadas. Além disso, o sofrimento evidente dessas crianças era acompanhado por um dramático aumento dos níveis sanguíneos de ácidos graxos livres, uma medida relacionada à cetoacidose. No terceiro estágio dessas entrevistas, os pacientes se reuniam aos pais. Os pais normais e os pais com transtornos de comportamento continuavam como antes, mas os pais psicossomáticos desviavam seu conflito, ou trazendo os filhos para a sua discussão ou mudando de assunto e passando a falar dos filhos. Quando isso acontecia, os níveis de ácidos graxos livres dos pais caíam, enquanto os níveis das crianças continuavam subindo. Este estudo confirma, solidamente, as observações clínicas de que as crianças psicossomáticas são usadas (e se deixam usar) para regular o estresse entre os pais.

Minuchin, Rosman e Baker (1978) resumiram os resultados terapêuticos de 53 casos de anorexia nervosa com uso da terapia familiar estrutural. Após um curso de tratamento que incluiu hospitalização seguida por terapia familiar em regime ambulatorial, 43 crianças anoréxicas tinham “melhorado muito”, duas tinham “melhorado”, três não mostravam “nenhuma mudança”, duas estavam “pior” e três tinham abandonado o tratamento. Embora considerações éticas impeçam um tratamento controle com essas crianças gravemente doentes, o índice de melhora de 90% é impressionante, especialmente se comparado ao índice de mortalidade de 30% neste transtorno. Além disso, os resultados positivos no término foram mantidos em intervalos de seguimento de vários anos. A terapia familiar estrutural também mostrou ser efetiva no tratamento de asmáticos psicossomáticos e em casos de diabetes complicada por fatores psicossomáticos

(Minuchin, Baker, Rosman, Liebman, Milman e Todd, 1975).

Embora nenhum corpo de evidências empíricas tenha estabelecido que alguma abordagem terapêutica é consistentemente melhor que as outras, a terapia familiar estrutural provou ser efetiva em diversos estudos, incluindo vários que envolveram casos considerados muito difíceis. Duke Stanton mostrou que a terapia familiar estrutural pode ser efetiva para drogaditos e suas famílias. Em estudo bem controlado, Stanton e Todd (1979) compararam a terapia familiar com uma condição familiar de placebo e com terapia individual. A redução dos sintomas foi significativa com a terapia familiar estrutural; o nível de mudanças positivas foi mais que o dobro do obtido nas outras condições, e esses efeitos positivos persistiram em seguimentos aos 6 e aos 12 meses.

Mais recentemente, a terapia familiar estrutural foi aplicada com sucesso para estabelecer papéis parentais mais adaptativos em adictos à heroína (Grief e Dreschler, 1993) e como um meio de reduzir a probabilidade de jovens afro-americanos e latinos iniciarem uso de drogas (Santisteban, Coatsworth, Perez-Vidal, Mitrani, Jean-Gilles e Szapocznik, 1997). Outros estudos indicam que a terapia familiar estrutural tem a mesma efetividade que o treinamento em comunicação e treinamento em manejo comportamental para reduzir comunicação negativa, conflitos e expressão da raiva entre adolescentes diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e seus pais (Barkley, Guevremont, Anastopoulos e Fletcher, 1992). A terapia familiar estrutural também tem sido efetiva para tratar transtornos adolescentes, como transtornos de conduta (Szapocznik et al., 1989; Chamberlain e Rosicky, 1995) e anorexia nervosa (Campbell e Patterson, 1995).

RESUMO

Minuchin talvez seja mais conhecido pela habilidade de sua técnica clínica, mas sua teoria familiar estrutural tornou-se um dos modelos conceituais mais utilizados no campo. A teoria estrutural é tão popular por ser simples, inclusiva e prática. Os conceitos básicos – fronteiras, subsistemas, alinhamentos e comple-

mentaridade – são facilmente compreendidos e aplicados. Levam em conta o contexto individual, familiar e social, e fornecem uma estrutura organizadora muito clara para se compreender e tratar as famílias.

O princípio mais importante desta abordagem é que toda família tem uma estrutura, e essa estrutura só se revela quando a família está em ação. Segundo esta visão, os terapeutas que deixam de considerar a estrutura familiar completa e só intervêm em um subsistema provavelmente não conseguirão efetuar mudanças duradouras. Se o demasiado envolvimento de uma mãe com seu filho faz parte de uma estrutura que inclui distância do marido, nenhuma quantidade de terapia apenas para a mãe e o filho conseguirá provocar mudanças básicas na família.

Os subsistemas são unidades da família baseados em função. Se a liderança de uma família é assumida pelo pai e por uma filha, então eles, e não o marido e a mulher, é que são o subsistema executivo. Os subsistemas são circunscritos e regulados por fronteiras interpessoais. Nas famílias saudáveis, as fronteiras são suficientemente claras para proteger a independência e a autonomia, e suficientemente permeáveis para permitir mútuo apoio e afeição. As famílias emaranhadas são caracterizadas por fronteiras difusas; as famílias desligadas, por fronteiras rígidas.

A terapia familiar estrutural visa a resolver os problemas apresentados reorganizando a estrutura familiar. A avaliação, portanto, requer a presença de toda a família, para que o terapeuta possa observar a estrutura subjacente às interações familiares. No processo, o terapeuta pode distinguir estruturas disfuncionais e funcionais. As famílias com dores de crescimento não devem ser tratadas como patológicas.

Os terapeutas familiares estruturais precisam evitar ser *alistados* como membros das famílias com as quais trabalham. Eles começam acomodando-se ao jeito habitual de funcionamento da família, a fim de evitar a resistência. Depois de conquistar a confiança da família, o terapeuta promove uma interação familiar, assumindo um papel descentralizado. Desta posição, ele pode observar e fazer uma avaliação estrutural, que inclui o problema e a organização que o mantém. Essas avaliações são enquadradas em termos de fronteiras e

subsistemas, facilmente conceitualizados como mapas bidimensionais, utilizados para encontrar caminhos de mudança.

Depois de ter sucesso ao se reunir à família e avaliá-la, o terapeuta passa a ativar estruturas dormentes, utilizando técnicas que alteram alinhamentos e mudam o poder dentro de e entre subsistemas. Essas técnicas de reestruturação são concretas, intensas e, às vezes, dramáticas. Entretanto, seu sucesso depende tanto da reunião e avaliação quanto do poder das técnicas em si.

Embora a terapia familiar estrutural seja tão profundamente identificada com Salvador Minuchin que houve um momento em que ambos eram sinônimos, seria uma boa idéia diferenciar o homem do modelo. Quando pensamos na terapia familiar estrutural, tendemos a lembrar a abordagem conforme descrita em *Families and family therapy*, publicado em 1974. Esse livro continua a ser uma ótima introdução à teoria estrutural, mas enfatiza apenas as técnicas que Minuchin preferia na época. O próprio Minuchin evoluiu consideravelmente nos últimos 30 anos, de um jovem terapeuta às vezes brusco, sempre pronto a desafiar as famílias, para um terapeuta mais experiente, ainda desafiador, mas muito mais gentil em sua abordagem. Se alguns dos exemplos deste capítulo lhe pareceram agressivos demais, talvez você tenha razão. Algumas dessas vinhetas foram retiradas da década de 1970, quando os terapeutas familiares tendiam a preferir um estilo confrontacional. Embora o estilo confrontacional tenha caracterizado alguns praticantes da terapia familiar estrutural, este nunca foi um aspecto essencial da abordagem.

Minuchin também evoluiu conceitualmente, de um foco quase exclusivo nas interações interpessoais para uma consideração das perspectivas cognitivas que orientam essas interações e as raízes passadas dessas perspectivas (Minuchin, Nichols e Lee, no prelo). Contudo, a abordagem estrutural que ele criou também existe independentemente de seu trabalho e está corporificada na literatura definitiva sobre este modelo (por exemplo, Minuchin, 1974; Minuchin e Fishman, 1981; Colapinto, 1991; Minuchin e Nichols, 1993), assim como no trabalho de seus alunos e colegas. O modelo estrutural orienta o terapeuta a olhar além do conteúdo dos problemas, e até além da di-

nâmica da interação, para a organização familiar subjacente, que sustenta e limita essas interações. Muita coisa mudou desde 1974, mas o modelo estrutural ainda permanece firme e continua sendo a maneira mais amplamente utilizada de compreender o que acontece na família nuclear.

LEITURAS RECOMENDADAS

Colapinto J. 1991. Structural family therapy. In *Handbook of family therapy*. Vol. II. A. S. Gurman e D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/ Mazel.

Minuchin, S. 1974. *Families and family therapy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., e Fishman, H. C. 1981. *Family therapy techniques*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., Lee, W-Y., e Simon, G. M. 1996. *Mastering family therapy: Journeys of growth and transformation*. New York: Wiley.

Minuchin, S., e Nichols, M. P. 1993. *Family healing: Tales of hope and renewal from family therapy*. New York: Free Press.

Minuchin, S., Nichols, M. P., e Lee, W-Y. No prelo. *A four-step model for assessing couples and families: From symptom to psyche*. Boston: Allyn & Bacon.

Nichols, M. P. 1999. *Inside family therapy*. Boston: Allyn & Bacon.

Nichols, M. P., e Minuchin, S. 1999. Short-term structural family therapy with couples. In *Short-term couple therapy*, J. M. Donovan, ed. New York: Guilford Press.

REFERÊNCIAS

Barkley, R., Guevremont, D., Anastopoulos, A., e Fletcher, K. 1992. A comparison of three family therapy programs for treating family conflicts in adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 60, p. 450-463.

Campbell, T., e Patterson, J. 1995. The effectiveness of family interventions in the treatment of physical illness. *Journal of Marital and Family Therapy*. 21, p. 545-584.

Chamberlain, P., e Rosicky, J. 1995. The effectiveness of family therapy in the treatment of adolescents with conduct disorders and delinquency. *Journal of Marital and Family Therapy*. 21, p. 441-459.

Colapinto, J. 1991. Structural family therapy. In *Handbook of family therapy*. Vol. II. A. S. Gurman e D. P. Kniskern, eds. New York: Brunner/Mazel.

Elizur, J., e Minuchin, S. 1989. *Institutionalizing madness: Families, therapy, and society*. New York: Basic Books.

Grief, G., e Dreschler, L. 1993. Common issues for parents in a methadone maintenance group. *Journal of Substance Abuse Treatment*. 10, p. 335-339.

Minuchin, S. 1974. *Families and family therapy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., Baker, L., Rosman, B., Liebman, R., Milman, L., e Todd, T. C. 1975. A conceptual model of psychosomatic illness in children. *Archives of General Psychiatry*. 32, p. 1031-1038.

Minuchin, S., e Fishman, H. C. 1981. *Family therapy techniques*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., Lee, W-Y., e Simon, G. M. 1996. *Mastering family therapy: Journeys of growth and transformation*. New York: Wiley.

Minuchin, S., Montalvo, B., Guernsey, B., Rosman, B., e Schumer, F. 1967. *Families of the slums*. New York: Basic Books.

Minuchin, S., e Nichols, M. P. 1993. *Family healing: Tales of hope and renewal from family therapy*. New York: Free Press.

Minuchin, S., Nichols, M. P., e Lee, W-Y. No prelo. *A four-step model for assessing couples and families: From symptom to psyche*. Boston: Allyn & Bacon.

Minuchin, S., Rosman, B., e Baker, L. 1978. *Psychosomatic families: Anorexia nervosa in context*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Santisteban, D., Coatsworth, J., Perez-Vidal, A., Mitrani, V., Jean-Gilles, M., e Szapocznik, J. 1997. Brief structural/strategic family therapy with African American and Hispanic high-risk youth. *Journal of Community Psychology*. 25, p. 453-471.

Simon, G. M. 1995. A revisionist rendering of structural family therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*. 21, p. 17-26.

Stanton, M. D., e Todd, T. C. 1979. Structural family therapy with drug addicts. In *The family therapy of drug and alcohol abuse*, E. Kaufman e P. Kaufmann, eds. New York: Gardner Press.

Szapocznik, J., Rio, A., Murray, E., Cohen, R., Scopetta, M., Rivas-Vazquez, A., Hervis, O., Posada, V., e Kurtines, W. 1989. Structural family versus psychodynamic child therapy for problematic Hispanic boys. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 57, p. 571-578.